

Amenorrea primaria y secundaria

1. Introducción y relevancia clínica

La **amenorrea** es la **ausencia de menstruación** y representa un signo —no una enfermedad en sí misma— que puede originarse por **alteraciones anatómicas, endocrinas o funcionales** en cualquiera de los niveles del **eje hipotálamo–hipófisis–ovario–útero**.

Es un motivo frecuente de consulta ginecológica y de **preguntas EUNACOM**, ya que su abordaje exige un **razonamiento clínico estructurado**, con interpretación de pruebas hormonales y ecográficas.

Clasificación:

- **Amenorrea primaria:** ausencia de menarquia a los 15 años con caracteres sexuales secundarios normales, o a los 13 años sin desarrollo puberal.
- **Amenorrea secundaria:** ausencia de menstruación por ≥ 3 ciclos consecutivos o ≥ 6 meses en una mujer previamente menstruante.

□ En EUNACOM:

- Amenorrea **primaria** = **nunca menstruó**.
- Amenorrea **secundaria** = **dejó de menstruar**.

La **primera causa siempre debe descartarse: embarazo**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El ciclo menstrual depende de la interacción de cuatro niveles funcionales:

Nive	Estructura	Ejemplo de alteración	Tipo de hipogonadismo
I			

I	Hipotálamo	Estrés, anorexia, ejercicio extremo	Hipogonadismo hipogonadotrópico
II	Hipófisis	Prolactinoma, Sheehan, tumores	Hipogonadismo hipogonadotrópico
III	Ovario	Insuficiencia ovárica, Turner, radiación	Hipogonadismo hipergonadotrópico
IV	Útero/vagina	Sinequias (Asherman), agenesia uterina	Eugonadismo

La **amenorrea se produce cuando se interrumpe el eje** en cualquiera de estos niveles, afectando la ovulación, la secreción hormonal o la integridad anatómica del tracto genital.

3. Amenorrea primaria

a. Definición

Ausencia de menarquía a:

- 15 años con desarrollo sexual secundario.
- 13 años sin desarrollo mamario (telarca).

b. Causas principales según desarrollo puberal

Caracteres sexuales secundarios	Presencia de útero	Diagnóstico probable
Ausentes	Ausente	Disgenesia gonadal (Turner, 45,X0) o defecto enzimático (17 α -hidroxilasa).

Ausentes	Presente	Hipogonadismo hipogonadotrópico (Kallmann, anorexia, tumores hipofisarios).
Presentes	Ausente	Agnesia mülleriana (síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser).
Presentes	Presente	Obstrucción del flujo menstrual (himen imperforado, tabique vaginal).

c. Causas frecuentes

- **Disgenesia gonadal (Turner 45,X0)** → FSH alta, estradiol bajo, talla baja, cuello alado.
- **Síndrome de Rokitansky (agenesia uterina)** → desarrollo mamario normal, ausencia uterina en ecografía.
- **Síndrome de insensibilidad a andrógenos (testicular feminization)** → cariotipo 46,XY; genitales externos femeninos, vello púbico escaso.
- **Hipogonadismo hipogonadotrópico** → FSH/LH bajas; causas funcionales (estrés, peso) o genéticas (Kallmann).

4. Amenorrea secundaria

a. Definición

Ausencia de menstruación por:

- ≥ 3 ciclos consecutivos o ≥ 6 meses en mujer previamente menstruante.

b. Causas más frecuentes

Etiología	Mecanismo	Ejemplo
-----------	-----------	---------

Gestacional	Embarazo	Causa más común → test β -hCG positivo
Hipotalámica funcional	Inhibición GnRH	Estrés, ejercicio, anorexia
Hipofisaria	Déficit de gonadotropinas o hiperprolactinemia	Prolactinoma, síndrome de Sheehan
Ováricas	Falla ovárica prematura, SOP	FSH alta (falla), LH alta (SOP)
Uterinas	Destrucción o sinequias endometriales	Síndrome de Asherman

□ En Chile, la **amenorrea hipotalámica funcional** es frecuente en adolescentes y mujeres con estrés académico o bajo peso.

5. Algoritmo diagnóstico

Paso 1:

Descartar embarazo

→ Prueba de β -hCG en orina o suero.

Paso 2:

Dosar FSH, LH, estradiol, prolactina y TSH

- **Prolactina alta** → hiperprolactinemia → RM hipófisis.
- **TSH anormal** → disfunción tiroidea.
- **FSH/LH bajas + estradiol bajo** → hipogonadismo hipogonadotrópico (nivel I-II).
- **FSH/LH altas + estradiol bajo** → falla ovárica (nivel III).

- **FSH/LH normales + estradiol normal** → obstrucción del flujo o Asherman (nivel IV).

Paso 3:

Test de progesterona (test de desafío)

- Administrar medroxiprogesterona 10 mg/día × 5–10 días.
- **Sangrado positivo** → endometrio estrogénicamente estimulado = anovulación.
- **Sangrado negativo** → hipoestrogenismo o causa estructural → continuar estudio.

Paso 4:

Test combinado estrógeno + progesterona

- Si sangrado tras combinación → hipoestrogenismo.
- Si no hay sangrado → causa anatómica (útero no responde).

Paso 5:

Imagenología

- **Ecografía pélvica:** útero, ovarios, endometrio.
- **RM hipófisis:** si sospecha tumoral o hiperprolactinemia persistente.
- **Histeroscopia:** sospecha de sinequias uterinas.

6. Diagnósticos diferenciales principales

Diagnóstico	FSH	LH	Estradiol	Características
Embarazo	↓	↓	↑	β-hCG positiva

SOP	Normal/alta	↑	Normal	LH/FSH >2, ovarios poliquísticos
Falla ovárica prematura	↑↑	↑↑	↓	Menopausia <40 años
Hiperprolactinemia	↓	↓	↓	Galactorrea, cefalea, RM alterada
Hipotiroidismo	—	—	↓	TSH ↑, PRL ↑
Amenorrea hipotalámica funcional	↓	↓	↓	Estrés, ejercicio, peso bajo
Síndrome de Asherman	Normal	Normal	Normal	Antecedente de legrado, sinequias en eco/histeroscopia

7. Tratamiento (según causa)

Causa	Enfoque terapéutico
Embarazo	Orientación prenatal o interrupción según caso.
Hiperprolactinemia	Agonistas dopaminérgicos (cabergolina, bromocriptina).
Hipotiroidismo	Levotiroxina.
Falla ovárica	Terapia hormonal de reemplazo hasta edad promedio de menopausia.

SOP Pérdida de peso, anticonceptivos combinados, metformina.

Amenorrea funcional Nutrición, manejo del estrés, suspensión de ejercicio extremo.

Síndrome de Asherman Histeroscopia operatoria y restauración endometrial.

☐ Toda mujer con hipoestrogenismo crónico requiere **protección ósea (calcio, vitamina D, THS si corresponde)**.

8. Complicaciones y pronóstico

Etiología	Complicación	Pronóstico
Falla ovárica	Osteopenia, infertilidad	Irreversible
Hipogonadismo central	Infertilidad, hipoestrogenismo	Reversible con tratamiento
SOP	Infertilidad, hiperplasia endometrial	Controlable
Hiperprolactinemia	Galactorrea, infertilidad	Excelente con agonistas
Asherman	Infertilidad, aborto habitual	Variable según extensión

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐

Perlas

1. **Amenorrea primaria** = nunca menstruó; **secundaria** = dejó de hacerlo.
2. **Primer examen en toda amenorrea:** prueba de **embarazo**.
3. **FSH/LH altas + estradiol bajo** → **falla ovárica**.
4. **FSH/LH bajas + estradiol bajo** → **hipogonadismo central**.
5. **Test de progesterona positivo** = endometrio expuesto a estrógenos → **anovulación**.
6. **Asherman:** sinequias uterinas postlegrado → ausencia de menstruación con FSH/LH normales.
7. **Turner (45,X0):** causa más común de amenorrea primaria con FSH alta y talla baja.



Errores frecuentes

- No descartar embarazo antes de estudiar otras causas.
- Interpretar ausencia de sangrado tras test de progesterona como “anovulación”.
- Omitir evaluación tiroidea y prolactina.
- Asumir SOP ante cualquier anovulación sin criterios de Rotterdam.
- Indicar THS sin valorar deseo reproductivo o edad.

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Amenorrea primaria:** sin menarquia a los 15 años o sin telarca a los 13.
2. **Amenorrea secundaria:** ausencia de menstruación ≥ 3 ciclos o ≥ 6 meses.
3. **Siempre descartar embarazo primero.**
4. **Test de progesterona:** sangrado = anovulación; no sangrado = hipoestrogenismo o causa anatómica.
5. **FSH/LH altas** → **falla ovárica**; **bajas** → **disfunción central**.

6. **Asherman y agenesia uterina:** causas uterinas con hormonas normales.
7. Tratamiento depende de la causa, pero toda paciente requiere **evaluar fertilidad, hueso y bienestar emocional.**